Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornellas, 50, sala 1001 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - balcao virtual :(51) 993742438 - Email: frpoacent5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5117729-60.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: MARCO AURELIO ROHDE MARTINS (SUCESSÃO)
AUTOR: JULIANA MARTINS
AUTOR: BRUNA MARTINS
AUTOR: HENRIQUE MARTINS
AUTOR: MARCIA MARIA PAZ AMORIM
RÉU: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

MARCO AURELIO ROHDE MARTINS (Sucessão), representado pelos sucessores JULIANA MARTINS, BRUNA MARTINS, HENRIQUE MARTINS e MARCIA MARIA PAZ AMORIM, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de **ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**. Narrou, em síntese, que mantém vínculo contratual de assistência de saúde com a Ré desde 01 de fevereiro de 2024. Afirmou que no dia 20 de abril de 2024, cerca de três meses após a adesão ao plano de saúde, recebeu o diagnóstico de neoplasia maligna no pâncreas. Destacou houve agravamento da doença, circunstância que acarretou a necessidade de internação e posterior encaminhamento para tratamento quimioterápico com urgência, em razão da agressividade do quadro. Relatou que houve negativa de corbertura do tratamento por parte da requerida, em razão do não cumprimento do período de 180 dias de carência previsto no contrato. Abordou sobre o direito aplicável ao caso. Pediu gratuidade judiciária e tramitação preferencial. Requereu, liminarmente, a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar o fornecimento do tratamento quimioterápico prescrito ao autor (quimioterapia paliativa de primeira linha com protocolo Gencitabina + Nabpaclitaxel) no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de imposição de multa diária não inferior a R$ 50.000,00 em caso de descumprimento. Ao final, postulou a procedência do pedido para confirmar o deferimento da tutela de urgência postulada. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Foi invertido o ônus probatório e deferida a tutela de urgência, para determinar que a demandada disponibilize, no prazo de 2 dias, o tratamento quimioterápico prescrito ao autor em caráter de urgência (quimioterapia paliativa de primeira linha com protocolo Gencitabina + Nabpaclitaxel) na forma indicada na guia de solicitação de quimioterapia, bem como determinada a citação (evento 4, DESPADEC1).

Na sequênca, foi deferido o benefício de gratuidade da justiça à parte autora (evento 9, DESPADEC1).

Citada (evento 12, CERTGM1), a ré ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apresentou contestação (evento 20, CONT1). Preliminarmente, informou acerca do cumprimento da tutela de urgência e requereu gratuidade da justiça. No mérito, afirmou sobre a legalidade da negativa, pois o autor não cumpriu integralmente o período de carência exigido no contrato. Negou a existência de situação de urgência, em razão do caráter ambulatorial do tratamento postulado. Asseverou sobre a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requereu a revogação da tutela de urgência. Pugnou o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos contidos na exordial. Juntou documentos.

Irresignada, a parte ré interpôs agravo de instrumento da decisão que concedeu a tutela de urgência, de modo que foi negado provimento ao recurso (evento 17, RELVOTO1).

Sobreveio réplica (evento 25, RÉPLICA1).

Instadas acerca da dilação probatória (evento 26, ATOORD1), ambas manifestaram desinteresse (evento 31, PET1 e evento 32, PET1).

A parte demandada foi intimada para comprovar a necessidade do benefício postulado (evento 34, DESPADEC1).

Com a juntada de documentos (evento 40, PET1), foi indeferido o benefício postulado pela ré (evento 43, DESPADEC1).

A demandada notificou o falecimento do autor (evento 51, CERTOBT2) e requereu a suspensão do feito com efeitos retroativos à data do óbito, bem como a habilitação dos herdeiros no feito para prosseguimento (evento 51, PET1).

O feito foi suspenso e foi determinada a regularização do polo ativo (evento 55, DESPADEC1 e evento 63, DESPADEC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

DECIDO.

Reassumi a jurisdição dia 6/8/2025, após licença regulamentar de estudos.

Considerando os limites a que se restringiu a controvérsia, dispensável a produção de outros meios de prova, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontra o processo (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).

Da retificação do polo ativo.

Inicialmente, verifico que os sucessores JULIANA MARTINS, BRUNA MARTINS, HENRIQUE MARTINS e MARCIA MARIA PAZ AMORIM foram cadastrados no polo ativo na qualidade de autores.

Entretanto, consigno que os sucessores do extinto não se confundem com a parte demandante, de modo que a sua integração no polo ativo foi determinada tão somente para assegurar a adequada representação do autor no presente feito.

Portanto, retifique-se o polo ativo para que os sucessores figurem como representantes da parte autora, e não autores entre si.

Inexistem preliminares pendentes de análise, ao passo que se fazem presentes os pressupostos processuais e as demais condições da ação, devendo-se iniciar o exame do mérito.

Da responsabilidade da ré pela cobertura do procedimento.

Destaco que os planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, salvo as modalidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.

Nesse norte, estabelece a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

> ***Súmula 608*** *– Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

Com efeito, o contrato é de adesão e, por tal razão, é manifesta a mitigação do ***pacta sunt servanda***, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte da aderente, beneficiária do crédito e, nessa condição, vulnerável contratualmente.

Nesse sentido, é possível a adequação dos contratos de seguros aos ditames legais, de modo a viabilizar, se for o caso, a decretação da nulidade ***pleno iure*** das cláusulas que estipulem obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, melhor dizendo, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do artigo 6º, inciso V e artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, acrescento ser um direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua o artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista, ***in verbis***:

> *Art. 6º São direitos básicos do consumidor:*
>
> *(...)*
>
> *III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;*

Para mais, é consabido que as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, sobretudo, quando se trata de contrato que tem como objetivo a prestação de serviços ligados a saúde das pessoas, consoante art. 6, incisos IV e VIII e art. 47, ambos do CDC.

Nesse sentido, é o entendimento do TJRS:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. NEFRECTOMIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. (...) Aliás, sobre o tema, o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3.* ***Não há qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes de exclusão de cobertura de realização de procedimento cirúrgico por videolaparoscopia, serviço que originou a presente demanda.*** *4.Restrições de direito devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, o que não ocorreu no caso em tela, em afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista.* ***Ressalte-se que a vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, e cláusulas restritivas de direito não dão margem a interpretações extensivas.*** *5.****A omissão no contrato quanto à exclusão de cobertura deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor.*** *Inteligência do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Negaram provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70048874945, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/07/2012)*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ECOGRAFIA TRANSRETAL DE PRÓSTATA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. SENTENÇA MANTIDA. Aplica-se o CDC, por se tratar de relação de consumo.* ***Em não havendo qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes, acerca da exclusão de cobertura de realização do procedimento que o autor necessita realizar, a negativa da operadora se mostra abusiva. As cláusulas restritivas devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, sob pena de, em não o fazendo, infringir o art. 47 do CDC. A vedação de cobertura não consta taxativamente no contrato, não podendo tais cláusulas ser interpretadas de maneira extensiva.*** *APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70049268527, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 27/06/2012)*

Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos dos regramentos acima referidos.

Feita estas considerações, prossigo.

Com efeito, é incontroverso que a doença enfrentada pela parte autora possui cobertura pelo plano de saúde, uma vez que há expressa previsão do contrato celebrado entre as partes nesse sentido (cláusula n.º 17 - evento 1, CONTR7).

Além disso, a ré não apresentou insurgência quanto ao ponto, apenas justificou a negativa com base na necessidade de cumprimento do prazo de carência (evento 20, CONT1) e, mais especificamente, a inaplicabilidade do prazo diferencial de 24 horas previsto em lei, porquanto a situação enfrentada pelo autor não estaria enquadrada em eventual caso de urgência.

Dessa forma, a controvérsia da lide se resume à análise a respeito da negativa de cobertura do tratamento quimioterápico fornecida pela ré, sob o argumento de que a situação vivenciada pelo autor não correspondia a caso de urgência.

Compulsados os autos, verifico que o laudo elaborado pelo médico que acompanhava o autor solicitou a realização do tratamento quimioterápico em caráter de "*máxima urgência*", sob pena de "*aumentar o risco de morte*" (evento 1, ATESTMED15).

PACIENTE

Marco Aurelio Rohde Martins CPF: 253.366.900-82

Atestado Médico

RELATÓRIO MÉDICO

O Sr MARCO AURELIO ROHDE MARTINS, 66 anos, é portador de Neoplasia Maligna de Pancreas, patologia sob CID C25.9, do tipo carcinoma indiferenciado. Paciente recebeu o diagnóstico em abril de 2024 (23.04.2024), já com exames de estadiamento revelando metastáses hepáticas e peritoneais, estadio clinico IV. Evoluiu com obstrução de via biliar e colangite associada, sendo submetido a implante de protese metalica na via. Na sequencia apresentou quadro compativel com colecistite associado a importante distensao vesicular necessitanto procedimento de colecistostomia associado a antibioticoterapia. Foi recentemente, em 06.06.2024, subemtido a TC de abdome para reavaliação já apresentando progressão das lesões hepáticas e peritoneiais. Portanto, paciente portador de neoplasia de padrão agressivo, metastática, em franca progressão, ainda sem iniciar tratamento oncologico.

Neste cenário, paciente deve ser submetido a quimioterapia paliativa de primeira linha com protocolo Gencitabina + Nabpaclitaxel, conforme solicitação enviada ao convenio, com máxima urgência. A sua ausência, ou demora na instituição do tratamento, pode permitir o agravo/progressão da doença e aumentar o risco de morte, reforçando a necessidade de liberação urgente. Cabe esclarecer que a minha indicação está baseada em critérios médicos, embasados em literatura cientifica, livre de qualquer conflito de interesse e levando em consideração todos os princípios do Código de Ética Médica.

08 de Junho de 2024

Pois bem.

Destaco que o caso dos autos atrai sobremaneira a incidência da Lei n.º 9.656/98, que regula os planos de saúde.

No ponto, sinalizo que os artigos 12, inciso V, e 35-C, dispõem sobre a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos emergenciais que acarretem risco à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, circunstâncias em que o período de carência ficará restrito ao prazo máximo de vinte e quatro horas.

Colaciono:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *V - quando fixar períodos de carência:*
>
> *a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;*
>
> *b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;*
>
> ***c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;***
>
> *(...)*
>
> *Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:*
>
> ***I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;***
>
> *II - de **urgência**, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;*
>
> *III - de planejamento familiar.*

Nesse contexto, entendo que a situação de urgência restou plenamente demonstrada nos autos, sobretudo diante do laudo médico ora destacado, no qual essa circunstância está expressamente apontada.

Da mesma forma, ressalto que o profissional da sáude é quem possui condições para determinar se o quadro de seu paciente deve ser considerada urgente ou não, e não o plano de saúde, ao qual cabe tão somente observar os termos da prescrição médica que eventualmente refira a existência de tal situação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula n.º 579, fixou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que limita o período de internação nos casos de urgência ou emergência, ou que estabelece carência para utilização de serviços se ultrapassado o prazo de 24 horas.

Cito:

> ***Súmula 597****: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou urgência é considerada absuva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.*

Nesse sentido é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU DE EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*
> *1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou de emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora.*
> *2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme o disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ.*
> *3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais.*
> *4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.*
> *5. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.*
> *6. Agravo interno desprovido.*
> *(AgInt no AREsp n. 2.626.405/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)*
>
> *CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DEVER INDENIZATÓRIO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.*
> *1. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação a 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ.*
> *2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).*
> *3. Agravo interno a que se nega provimento.*
> *(AgInt no AREsp n. 2.526.989/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)*

Por essas razões, entendo abusiva a negativa de fornecimento do tratamento quimioterápico apresentada pela demandada, razão pela qual a pretensão do autor será julgada procedente, porquanto este faz jus ao tratamento nos termos da prescrição médica.

De todo modo, considerando o óbito do demandante, a procedência da demanda se justifica apenas para confirmar a liminar, visto que esta fora examinada em cognição sumária, o que implica, portanto, a necessidade de verificá-la em juízo exauriente.

POSTO ISSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **confirmo os efeitos da tutela de urgência** e **JULGO PROCEDENTES** os pedidos intentados por MARCO AURELIO ROHDE MARTINS (Sucessão) em face de **ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** para **DISPONIBILIZAR** o tratamento quimioterápico prescrito ao autor em caráter de urgência (quimioterapia paliativa de primeira linha com protocolo Gencitabina + Nabpaclitaxel), na forma indicada na guia de solicitação de quimioterapia.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais. Considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda, fixo os honorários advocatícios em favor do procurador da autora em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 12.967,50), com fulcro no artigo 85, § 2º, parte final do Código de Processo Civil.

Interposto(s) o(s) recurso(s), restará ao cartório, por meio de ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, e, consequentemente, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Igual procedimento deverá ser adotado na hipótese de recurso adesivo.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE KREUTZ, Juiz de Direito**, em 05/09/2025, às 10:27:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10082796710v15** e o código CRC **e33f37ec**.